담낭 폴립, 어떻게 추적할까요?

핵심은 크기 · 모양 · 담낭벽 · 성장 변화입니다. 대부분은 양성이지만, 기준에 맞춰 놓치지 않고 관찰합니다.

처음 발견되면 확인할 4가지



항목	결과지에서 볼 것
① 크기(mm)	가장 긴 지름. **1cm는 10mm**입니다.
② 모양	**자루가 있는 폴립**은 상대적으로 안심되는 모양이 많지만 크기 변화는 확인합니다. **벽에 넓게 붙은 폴립**은 성장·담낭벽 변화를 더 주의해서 봅니다.
③ 담낭벽	두꺼워짐·불규칙이 있으면 더 주의합니다.
④ 변화	이전보다 커졌거나 모양이 달라졌는지 비교합니다.

크기와 의심 소견에 따른 추적 방향

크기	의심 소견	방향
6mm 미만	없음	관찰 정기 추적은 권하지 않습니다.
	있음	추적 초음파 추적을 권합니다.
6–9mm	없음 · 50세 미만	정기 추적 1년마다 초음파, 5년간
	있음(50세 미만) 또는 50세 이상 (소견 없음)	밀착 추적 첫 1년은 6개월마다, 이후 4년은 1년마다 초음파
	있음 · 50세 이상	개별 상담 수술 또는 초음파 추적(첫 1년 6개월마다, 이후 1년마다) 중 상담해 정합니다.
10–14mm	없음	개별 상담 수술 또는 초음파 추적(첫 1년 6개월마다, 이후 1년마다) 중 상담해 정합니다.
	있음	수술 권고 수술이 가능한 상태라면 담낭절제술을 권합니다.
15mm 이상	크기 자체로 해당	수술 권고 수술이 가능한 상태라면 담낭절제술을 권합니다.

* 의심 소견 = 폴립 옆 담낭벽 두꺼워짐, 벽에 넓게 붙은 모양, 추적 중 뚜렷한 성장. 6–9mm 폴립이 5년간 변화가 없으면 추적 중단을 고려할 수 있습니다. 실제 간격은 영상 소견·나이·위험인자를 보고 진료실에서 정합니다.

수술 상담이 필요한 신호 · 왜 초음파로 추적하나요

수술 상담이 필요한 신호

- **15mm 이상**이거나, **10–14mm**에 의심 소견이 동반될 때
- 추적 중 분명히 커져 **10mm 또는 15mm 경계**를 넘을 때
- **벽에 넓게 붙은 모양**, 담낭벽 두꺼워짐·불규칙이 보일 때
- 다른 원인을 배제해도 담낭 관련 증상이 지속될 때
- **원발성 경화성 담관염**(담도에 염증·흉터가 생기는 병)이 있거나, 혈액 종양표지자 **CA 19-9**가 오르거나, 영상에서 암이 의심되면 개별 전문 진료

초음파로 추적하는 이유

- 담낭 폴립의 1차 평가는 **복부초음파**입니다.
- CT/MRI가 작은 폴립을 항상 더 잘 보는 것은 아니며, 암이 의심되거나 초음파가 불충분할 때 선택적으로 고려합니다.
- **방사선 없음 · 반복 비교 쉬움 · 작은 변화 관찰**

검사 전후 체크

검사 전

- **8시간 금식** 후 검사하면 담낭이 잘 펴져 더 정확합니다('복부초음파 검사 전 준비 안내' 참고).
- 가능하면 같은 병원에서 비교하거나 이전 결과지를 가져오세요.

결과를 볼 때

- 결과지의 **크기·모양·담낭벽·추적 권고**를 확인하세요.
- 통증은 폴립만으로 단정하지 않고 담석·위장질환도 함께 봅니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한복부영상의학회 담낭용종 권고 Korean J Radiol. 2025;26:102-134 · Foley KG 외 Eur Radiol. 2022;32:3358-3368 · Knight J 외 Abdom Radiol. 2024;49:3158-3165

본 자료는 환자 안내용 참고자료입니다. 초음파만으로 양성·악성을 100% 구분할 수 없으며, 최종 방침은 담당 의사와 상담해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/gallbladder-polyp-followup/